

SUMISIÓN QUÍMICA

Julio Tito Camino Acha, Marta Iglesias Vela, María Antonia Jiménez Lozano.

INTRODUCCIÓN

La sumisión química es el intento de la manipulación de la voluntad o comportamiento de las personas con fines delictivos: desde asalto sexual, atracos, robos, etc. Usando agentes químicos, como las sustancias psicoactivas.

Tipos de sustancias químicas.

Las sustancia idea es aquella que produzca efectos rápidos, máximo efecto a dosis mas pequeñas, soluble en medio acuoso y con mínimo sabor ni olor, buscando efectos de sedación, amnesia anterógrada, efectos alucinógenos y desinhibición, los mas usados son:

- Alcohol etílico.
- Benzodiacepinas (vida media - corta): principalmente flunitrazepam, alprazolam, diacepam.
- Hipnóticos: zolpidem, zopiclona.
- ketamina, fentanilo, atropina, escopolamina o burundanga, barbitúricos, ácido gammahidroxibutírico (GHB).
- Cannabinoides.
- Disolventes orgánicos.
- Drogas de abuso: opiáceos, cocaína, derivados alucinógenos, derivados anfetamínicos, LSD, etc.

Las vías de administración mas usada es la vía oral mezclándolas con bebidas, alimentos, café, zumos, cerveza y otras bebidas alcohólicas.

Tiempo de vida media plasmática

- Alprazolam: 6 - 27 horas.
- Cocaína: 0.7 - 1.5 horas.
- GHB: 0.3 - 1 hora.
- Etanol: 2 - 14 horas.
- Escopolamina: 2 - 6 horas.
- Lorazepam: 9 - 16 horas.
- Delta 9 - THC (Tetrahidrocannabinol): 20 - 36 horas.

Sospecha para consultar posible agresión sexual por sumisión química

La paciente puede plantear lo siguiente:

- Puede recordar haber sido agredida sexualmente.
- Se despierta desnuda o con la ropa desgarrada o a medio retirar con un desconocido o en un lugar que no recuerda haber acudido voluntariamente.
- Lesiones inexplicables en región anal, genital, oral u otras zonas del cuerpo.
- Conocidos que le explican que se encontraba en situación extraña y comprometedor con personas no conocidas a su entorno.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico fundamentalmente, basado en una anamnesis y exploración física dirigida y por sistemas, se confirmara con exámenes de laboratorio. Durante la anamnesis y exploración física deberá de estar presenta un personal sanitario, familiar o acompañante si lo permite la paciente a ser posible del mismo sexo.

Anamnesis

Se preguntara, motivo de consulta, los síntomas que presenta, si sospecha que ha sido víctima de delito sexual u otros. Se debe interrogar sobre el consumo voluntario de medicamentos (todos los tipos de medicamentos) y sustancias que consume como alcohol, drogas. Preguntar cantidad y cuando fue ingerido por ultima vez.

Exploración física

Se realizara de forma sistemática y ordenada por aparatos.

- **Aspecto general.** observar lesiones en mucosas y piel tipo arañazos, hematomas, heridas, etc.
- **Cabeza y cuello.** Heridas en cuero cabelludo, describir los hematomas u otras lesiones en cuello u otras zonas del cuerpo.
- **Tórax.** Valorar lesiones, heridas y auscultación cardíaca y pulmonar.
- **Abdomen.**
- **Área genital.** Derivar al área correspondiente para valoración (realizar interconsulta a ginecología para realizar examen adecuado).
- **Extremidades.**
- **Neurológico.**

Pruebas complementarias

Para realizar las pruebas específicas deberá de firmar la autorización o consentimiento la paciente o familiar si es menor de edad o tutor legal. Se mantendrá cadena de custodia y se aplicará el protocolo correspondiente.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio. Si sospecha de daño hepático o polifarmacia solicitar GOT, GPT, LDH, amilasa. Si sospecha de patología cardíaca isquémica debemos de solicitar CK, Troponina Ultrasensible.
- Coagulación básica.
- Gasometría venosa.
- ECG de 12 derivaciones con tira de ritmo.
- Ecografía abdominal. Si dolor intenso o contusión abdominal.
- TAC Craneal. Si sospecha de TCE moderado - severo, cuadro confusional, focalidad neurológica, cefalea, fiebre.
- Tóxicos en orina.
- Muestra de cabello, la obtiene el Médico Forense si hay apertura de diligencias.

TRATAMIENTO

De acuerdo a la clínica del paciente actuaremos según el ABCDE.

- Telemetría.
- Constantes vitales.
- vía venosa periférica.
- O₂ 2LX'endonasal o mascarilla si SatO₂: <94%.
- Suero fisiológico 500ml IV si hipotensión.
- Pantoprazol 1 amp IV.
- Primpran 1 amp IV. Si náuseas o vómitos.

- Paracetamol 1 gr IV. Si dolor o fiebre.

BIBLIOGRAFÍA

- Guía de detección clínica de la sumisión química. Comisión contra la violencia. Hospital Clínico San Carlos. Marzo 2016. Cordinador: Andrés Santiago Sáez. Servicio de Medicina Legal. Hospital Clínico San Carlos.
- <http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/introProtocoloComun.htm>
- García Repetto, R. Soria M.L. Sumisión química: reto para el toxicólogo forense. Rev Esp Med Legal. 2011; 37 (3): 105-112.